

Sicherheit entsteht im Verlauf

17. September 2026. Was chronisch kranke Menschen
von der Bildgebung brauchen.

Weiterwischen >

Warum das die Radiologie betrifft

- Das Motto in diesem Jahr: sichere Versorgung chronisch erkrankter Menschen, für ein gutes Leben
- Die WHO nennt Diagnoseverzögerungen ausdrücklich als eine der Schadensquellen in dieser Versorgung
- Wer chronisch krank ist, kommt über Jahre. Jede Untersuchung in dieser Reihe muss sitzen

bis zu 4 von 10

Menschen erleiden in der hausärztlichen und ambulanten Versorgung einen Schaden. So die obere Schätzung der WHO. Bis zu 80 Prozent davon gelten als vermeidbar.

Die Voruntersuchung danebenlegen

- Eine Verlaufskontrolle ohne die Vorbilder ist keine Verlaufskontrolle, sondern eine zweite Erstuntersuchung
- Vergleichbar wird ein Verlauf durch gleiche Schichtführung und gleiche Sequenzen, nicht allein durch dasselbe Gerät
- Und der Befund muss dort ankommen, wo weiterbehandelt wird. Chronisch Kranke haben selten nur einen Behandler

32 %

der radiologischen Zweitbefundungen weichen vom Erstbefund ab. In 19 Prozent aller Fälle ändert die Zweitbefundung das weitere Vorgehen. Metaanalyse aus 29 Studien.

KI als zweiter Blick, nicht als letzter

- Im deutschen Mammographiescreening stieg die Entdeckungsrate unter KI-Doppelbefundung von 5,7 auf 6,7 pro 1.000, ohne mehr Rückrufe
- In einer Münchner Studie an 1.861 Thoraxaufnahmen sank die Treffsicherheit bei Erguss und Rundherd, weil die Zahl falsch positiver Befunde stieg
- Beides zusammen ergibt die Regel: KI prüft mit, die ärztliche Letztverantwortung bleibt

Eine Verlaufsfrage offen?

Geben Sie uns mit der Überweisung an, welche Voruntersuchungen es gibt und wo sie liegen, auch die auswärtigen. Dann befunden wir im Verlauf und nicht nur im Bild.

www.rnz-radiologie.de

Quellen: WHO-Factsheet 2023 · WHO/APS 2026 · JACR 2018 ·
Nat Med 2025 · Acad Radiol 2026